

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Herniorrafia Inguinal Derecha + Hidrocelectomía + Circuncisión

Conforme a la Ley General de Salud No. 42-01 | República Dominicana

I. DATOS DEL PACIENTE

Apellidos y nombres completos	Liam Shael Corniel Montero	Expediente	LSC003
Fecha de nacimiento	25/09/2018	Edad	7 años 8 meses
Sexo	Masculino	Seguro / Póliza	Primera ARS de Humano — 2201258-001
Centro de salud / Hospital	Centro Médico de Especialidades Médicas (CMEM)		

II. DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL

Apellidos y nombres completos	Laura Paola Montero		
Cédula / Pasaporte		Relación con el paciente	Madre
Teléfono		Correo electrónico	

III. EQUIPO MÉDICO TRATANTE

Nombre del Cirujano Pediátrico	Dr. Lorenzo Ernesto Otaño Santiago	Exequátur	573-05
Institución / Especialidad	Centro Médico de Especialidades Médicas (CMEM) / Cirugía Pediátrica	No. CMD	19077
PSS / Cód. Prestador (Primera ARS de Humano)	10889		

IV. DIAGNÓSTICO

K40.0 — Hernia inguinal derecha

N43.3 — Hidrocele

N47.1 — Fimosis

V. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

1. Herniorrafia Inguinal Derecha:

La herniorrafia inguinal pediátrica es un procedimiento quirúrgico de baja complejidad que corrige el defecto de la pared abdominal en la ingle derecha a través del cual protruyen estructuras internas. Bajo anestesia general, incisión de ~3 cm en el pliegue inguinal, disección y ligadura alta del saco herniario con Vicryl. Cierre por planos con sutura absorbible. Alta el mismo día. Duración: 40–50 min.

2. Hidrocelectomía:

Cirugía para eliminar el líquido acumulado alrededor del testículo (hidrocele). Se hace una incisión en el escroto, se drena el líquido y se trata la membrana que lo produce.

3. Circuncisión:

La circuncisión pediátrica es un procedimiento quirúrgico de baja complejidad que consiste en la extirpación del prepucio estrecho para permitir la exposición libre del glande. Se realiza en sala de operaciones bajo condiciones estrictas de asepsia y antisepsia, con anestesia general. Comprende: evaluación y marcación del prepucio, incisión circunferencial controlada, extirpación del segmento prepucial, hemostasia cuidadosa y sutura con material absorbible. Duración: 20–30 min. Alta el mismo día.

VI. BENEFICIOS ESPERADOS

1. Herniorrafia Inguinal Derecha:

- Corrección definitiva del defecto herniario.
- Prevención del encarcelamiento herniario y sus complicaciones (necrosis, pérdida gonadal).
- Eliminación del dolor y la protrusión visible.
- Actividad normal del paciente a las 2 semanas.
- Alta tasa de éxito con técnica pediátrica.

3. Circuncisión:

- Resolución definitiva de la fimosis y libre exposición del glande.
- Prevención de infecciones urinarias recurrentes y episodios de balanitis.
- Mejora en la higiene íntima del paciente.
- Eliminación de molestias asociadas (dolor, presión, dificultad al orinar).
- Resultado funcional y estético satisfactorio.
- Calidad de vida sexual normal en la adultez.

VII. RIESGOS Y POSIBLES COMPLICACIONES

1. Herniorrafia Inguinal Derecha:

- Sangrado intraoperatorio o postoperatorio.
- Infección de la herida operatoria.
- Lesión del conducto deferente (<0.3%) o vasos del testículo (<0.5%).
- Hidrocele reactivo postoperatorio.
- Recurrencia de la hernia (<1% con técnica correcta).
- Retención urinaria transitoria.
- Riesgos anestésicos generales.

2. Hidrocelectomía:

Hematoma escrotal, infección, recurrencia, lesión del testículo o epidídimo.

3. Circuncisión:

Riesgos intraoperatorios:

- Sangrado intraoperatorio (excepcionalmente podría requerir transfusión).
- Lesión accidental del glande o la uretra (muy poco frecuente).

Complicaciones postoperatorias:

- Hemorragia postoperatoria en el sitio quirúrgico.
- Hematoma o seroma.
- Infección superficial o profunda de la herida operatoria.
- Edema (inflamación) del pene, habitualmente transitorio y autolimitado.
- Dehiscencia (apertura) parcial o total de la sutura.
- Estrechez del meato urinario que podría requerir tratamiento adicional.
- Resultado estético no esperado o asimetría de la cicatriz.
- Recurrencia o adherencias prepuciales residuales (<2%).

Riesgos anestésicos:

- Reacciones adversas a fármacos anestésicos.
- Náuseas, vómitos o agitación en el despertar.
- Complicaciones cardiorrespiratorias graves (muy poco frecuentes).

Ningún procedimiento invasivo está absolutamente exento de riesgos, incluyendo el de mortalidad, si bien esta posibilidad es bastante infrecuente. Ante cualquier complicación, todos los medios del centro estarán disponibles para solucionarla.

VIII. ALTERNATIVAS AL PROCEDIMIENTO

1. Herniorrafia Inguinal Derecha:

La hernia inguinal en pediatría no cierra espontáneamente y conlleva riesgo de encarcelación. El tratamiento quirúrgico es el estándar. Puede diferirse en casos electivos sin urgencia.

2. Hidrocelectomía:
Observación en menores de 2 años (puede resolver solo). En mayores o hidrocele persistente, la cirugía es el tratamiento definitivo.

3. Circuncisión:

- Aplicación tópica de crema con corticosteroides: efectiva en fimosis leve, uso prolongado.
- Prepuceplastia (ampliación del orificio prepucial sin extirpación): mayor tasa de recurrencia.
- Dilatación manual forzada: NO se recomienda (traumatizante, alta recurrencia).

Dada la evaluación clínica realizada, el equipo médico considera la circuncisión el tratamiento de elección.

IX. RIESGOS PERSONALIZADOS DEL PACIENTE

Condiciones / Comorbilidades	Ninguna referida por el tutor.
Alergias conocidas	
Medicamentos actuales	

X. INDICACIONES POSTOPERATORIAS ANTICIPADAS

1. Herniorrafia Inguinal Derecha:
Analgesia oral (ibuprofeno/acetaminofén). Apósito seco 48h. Baño normal a partir del 3.º día. Reposo relativo 2 semanas. Control en 7-10 días.

2. Hidrocelectomía:
Apósito compresivo 48h. Hielo local las primeras 24h. Analgesia oral. Reposo relativo 1 semana. Control en 7-10 días.

3. Circuncisión:
Pomada antibiótica local 5 días. Baños de asiento tibios desde 24h. Retiro de apósito en 48h. Sin baño de tina/piscina 2 semanas. Control en 7-10 días.

XI. DERECHOS DEL PACIENTE Y DEL REPRESENTANTE LEGAL

En cumplimiento de la **Ley General de Salud No. 42-01 de la República Dominicana** y los principios de bioética médica (autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia), el padre, madre o tutor legal declara conocer y ejercer los siguientes derechos:

- Derecho a recibir información veraz, completa, comprensible y oportuna sobre el diagnóstico, pronóstico, procedimiento, beneficios, riesgos y alternativas disponibles.
- Derecho a formular preguntas y recibir respuestas satisfactorias antes de otorgar o negar el consentimiento.
- Derecho a **revocar este consentimiento en cualquier momento antes del inicio del procedimiento**, sin consecuencias negativas para la atención del menor.
- Derecho a que los datos del paciente sean tratados con absoluta confidencialidad, conforme a la normativa vigente.
- Derecho a recibir copia de este documento firmado para sus archivos personales.
- Derecho a ser atendido con dignidad, respeto y sin discriminación.

XII. DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN

Yo, **Laura Paola Montero**, portador(a) de cédula/pasaporte No. _____, en calidad de **Madre** del/la menor **Liam Shael Corniel Montero**, de **7 años 8 meses** de edad, en pleno uso de mis facultades mentales, habiendo leído o escuchado el contenido de este consentimiento en su totalidad, **DECLARO**:

- Que he recibido información clara, fehaciente y ajustada a mis conocimientos sobre el diagnóstico, procedimiento, beneficios, riesgos y alternativas.
- Que he comprendido dicha información y he tenido la oportunidad de aclarar todas mis dudas en entrevista personal con el **Dr. Lorenzo Ernesto Otaño Santiago**.
- Que mis preguntas han sido respondidas a plena satisfacción.
- Que otorgo este consentimiento de forma **libre, voluntaria, informada y sin ningún tipo de presión o coacción**, actuando conforme a los artículos 14 y 28 de la Ley 42-01, basados en la Autonomía del Paciente y los Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica.

Por todo lo anterior, **DOY MI CONSENTIMIENTO y AUTORIZO expresamente la realización de: Herniorrafia Inguinal Derecha + Hidrocelectomía + Circuncisión** al menor antes identificado, así como los procedimientos complementarios, anestésicos o de urgencia que el equipo médico estime necesarios durante el acto quirúrgico o en el postoperatorio inmediato, siempre en beneficio de la salud e integridad del paciente.

XIII. FIRMAS Y VALIDACIÓN

PADRE / MADRE / TUTOR LEGAL

Laura Paola Montero
Cédula: _____

CIRUJANO PEDIÁTRICO

Dr. Lorenzo Ernesto Otaño Santiago
Exeq. 573-05 | CMD 19077

TESTIGO IMPARCIAL (OBLIGATORIO SI EL TUTOR NO SABE LEER O FIRMAR; OPCIONAL EN OTROS CASOS)

Nombre:

Cédula:

Firma:

DENEGACIÓN DE CONSENTIMIENTO (completar solo si aplica)

Yo, el/la abajo firmante, declaro que, habiendo recibido y comprendido la información contenida en este documento, **NIEGO MI CONSENTIMIENTO** para la realización del procedimiento descrito, asumiendo voluntariamente las consecuencias médicas que dicha decisión pueda conllevar para el menor a mi cargo.

Nombre:

Cédula:

Firma:

Instrucciones de archivo: 1. El original firmado debe incorporarse a la historia clínica y conservarse conforme a la normativa vigente. 2. Una copia firmada debe entregarse al padre, madre o tutor legal. 3. Este documento tiene plena validez legal conforme a la **Ley General de Salud No. 42-01**. 4. En caso de emergencia vital intraoperatoria, el equipo médico actuará conforme a los protocolos de urgencia sin requerir autorización adicional.